

إسم المريض رباعياً : رانيا مسعد سيد احمد
المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الدقي
رقم البطاقة : 27511072101801 رقم التليفون : 01113100131
العمر(تاريخ الميلاد) : 07-11-1975 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 جهة العلاج :
 ملاحظات :
 نفقات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رانيا مسعد سيد احمد National ID: 27511072101801	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of the lumbar spine

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS
Cassini
Koon
Koon
Koon
Koon



Nuclear Medicine Unit**وحدة الطب النووي****Name: Rania Mosaad Sayed****Date: 06/07/2023****Tc99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY****History**

- A 47-year-old lady with history of breast cancer.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- No evidence of bone secondaries could be seen.
- Exaggerated degenerative changes are noticed at different levels of spine and big joints.

IMPRESSION

- The skeleton is free from metastases.

Appreciated,**Dr. Hossam Sekkina, M.Sc.****Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine****25****Hotline****02 21 29 2000****w.ahramscan.com**

فرع حلوان : 64 شارع عبد الرحمن تقاطع شارع عبد الله فوق بنك مصر فرع نادي الاسمنت
فرع فيصل : 434 شارع الملك فيصل (فوق مستشفى تبارك للأطفال) الجيزة
فرع الدقي : 92 شارع التحرير - برج ساريدار الطبي - الدور الثالث
فرع شبرا : 128 شارع شبرا - امام قسم الساحل - بجوار سنترال شبرا
فرع أكتوبر : رنا مول - بعد الحصري والتوحيد والنور فوق سويز ماركت أولاد رجب - الدور الثاني

Name: رانيا مسعد سيد		
MR. : 1514		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient has hormone-receptor negative, HER2-positive breast cancer diagnosed in 2022. Adjuvant therapy with trastuzumab (Herceptin) was completed after one year, and the patient is now on routine follow-up with breast surgery monitoring (BSM) and periodic assessment (PAUS). The patient is receiving zoledronic acid (Zometa) every six months for known osteoporosis. Laboratory evaluation performed on the day of the zoledronic acid infusion showed normal calcium levels, appropriate bone health parameters, and the patient is maintained on a proton-pump inhibitor (PPI) for gastrointestinal protection. The patient remains under follow-up as of June 2026 with no evidence of disease on imaging and a free PAUS assessment.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : ندى حسن صلاح كامل	
يعتمد ,		



Pathology Report

Name رانيا مسعد سيد Age : 45years.

Clinical data: Right breast cancer (as per the involved report).

Specimen type: Slide revision

Date (Received): 17 /5/2021

Date (reported): 26 /5/2021

Lab. Number: SR-193 /21

Hospital Number :395/21

Gross Description:

Two blocks and eight stained slides labelled by the patient name.
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for
HER-2
HER-2 CLONE (4B5)

Microscopic Examination:

histopathological examination of the stained slides received reveals an infiltrating
malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of
pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is
moderate. Cellular and nuclear atypia are marked [grade III].

Examination of ER stained slide show No nuclear staining of the tumor cells.

Examination of PR stained slide show No nuclear staining of the tumor cells.

Examination of HER2 stained slide show intense complete membranous staining in > 10% of tumor cells.

Diagnosis:

Right breast cancer, Slide revision;

Invasive duct carcinoma grade III.

ER: Negative (0/8).

PR: Negative (0/8).

Her2: Positive (score 3+)

Prof. Dr. Iyuan Gouda.
Dr. Mouna Mohamed.



جهة الاصدار : فرع الجيزة

الى من يهمة الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للتأمين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "نقوى العمل والمعاملات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخلى بالمرأة المعيلة وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمين الاجتماعي والبحث تبين أن

المسيد (ة) رانيا مسعد سيد احمد بطاقة رقم 27511072101801

وطبقا الى فصل او استقالة او انتهاء مدة خدمة
يعتبر من الفئات غير المستفقيه بالتأمين الصحي
وشكرا

تحريرا في: 2021-6-9

الموافق المختص

محمد

الإدارة مركز نظم المعلومات
يقع...

مستش 25477



الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Rania Mossad Sayed Ahmed	Date : 03/04/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 1510/2021	17160

NON-ONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Compared to the attached study report dated 18.8.2022; the current study shows:

I Chest:

- Right MRM with myocutaneous flap showing no operative bed suspicious lesions.
- Middle and right upper lung lobes radiation pneumonitis.
- No currently noted sizable pulmonary nodules or pneumonic patches.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.

II Abdomen & pelvis:

- Small hiatus hernia.
- Enlarged liver with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- Stationary bilateral adnexal cysts, the larger still measures 4.5 x 6.2 cm.
- No abdominal or pelvic masses or collections



Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Rania Mossad Sayed Ahmed	Date : 03/04/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 1510/2021	17160

> No destructive bony lesion could be seen

Opinion:

- Follow up status showing still no pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.

Dr. Shaimaa Megahed, MSc

Dr. Amr Farouk, M.D.

Name: Rania Mossad Sayed Ahmed

ID: 3129618

Date: 19/05/2022

REPORT

Bone mineral density estimation (Densitometry)

TECHNIQUE:

- Estimation of the bone mineral density (B.M.D) was achieved at the left femur & left forearm radius regions as well as at the lumbar spine from L1 to L4 level, with TBS analysis of the spine, using dual energy absorptiometry (DEXA) technique.

FINDINGS:

- The total B.M.D at the lumbar spine = 0.896 gm/cm².
 - The total B.M.D at the left femur = 0.969 gm/cm².
 - The total B.M.D at the left forearm radius = 0.698 gm/cm².
 - The patient's B.M.D results were compared to & plotted against the peak B.M.D of young adults & the B.M.D of normal subjects of the same age & sex. Following WHO classification for osteoporosis it was noticed that:
 - Reduced total B.M.D. reading at the lumbar spine region that falls within the osteopenic range with T score of -2.4.
 - Normal total B.M.D. reading at the left femur region; however the selective B.M.D. reading at the left femoral neck region is reduced to fall within the osteopenic range with T score of -1.1.
 - Normal total B.M.D. reading at the left forearm radius region.
- Spine Trabecular bone score (TBS) measured 1.317.
- The 10 year probability of fracture adjusted for TBS:
- Major osteoporotic fracture = 1.7%.
 - Hip fracture = 0.1%.

OPINION:

- Osteopenia at the lumbar spine and left femoral neck regions.

Dr. Mostafa Khairy, MD

Trabecular bone score (TBS) is a novel analytical tool that captures information related to trabecular micro-architecture which helps in osteoporosis risk stratification and predicting fracture risk.



Exam Information:

<u>Patient Name:</u> نرجس محمد	<u>Date of birth:</u> 07/11/1975
<u>Arabic Name:</u> رانيا محمد	<u>Patient Gender:</u> F
<u>Patient RIS ID:</u> 368921	<u>Exam Date:</u> 03/05/2025
<u>Patient HIS ID:</u> 10110225007537	
<u>Written by:</u> Dr. Hoda Fathy	<u>Approved by:</u> Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (3/5/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP
Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Bilateral lower LV4 facet joint arthropathy.
- Active tracer uptake is noted traversing LV5/S1?? Porotic collapse for CT correlation.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

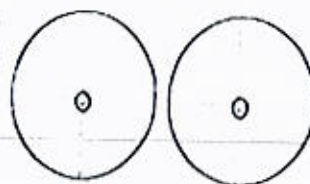
- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.
- CT lumbar is advised.



1941

01199 666 979

<u>Name</u>	اسماء بنت محمد
<u>Age</u>	9-5 Y
<u>MRN</u>	
<u>ID</u>	151cm-2021
<u>Co</u>	
<u>morbidity</u>	



was T₃N₁ clinically

Bx:	SM:
IHC: ER: -ve PR: -ve Hert: +ve +3 KITV:	Mets Workup:
IDC III T N M Rt LIQ mas.	
COMMENT: Rt. Breast Cancer, PT3, N1 Biopsy → IDC, G III.	
added (AC N4) Overweight + Height of (as below) + 12 lbs V-Pos Grd 1 + Nerve (1) r added 4 cells 119 Dr. Sybil Smith	
MDT OUTCOME & PLAN	

13/11/2021 $\rightarrow$ RF MRM (or SSM-ID flap) as planned

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
			